

ITEM 300 : TUMEUR DE L'ESTOMAC

- Incidence globale en diminution, reste fréquent et grave = 2^{ème} cause de mortalité mondiale par cancer
- Zone à haut risque = **Asie, Amérique du Sud et centrale** ; et zone à bas risque = Europe de l'Ouest, Amérique Nord
- En France : 5^{ème} cancer le plus fréquent (2^{ème} cancer digestif), âge moyen = **70 ans**, prédominance masculine (1,7)
- ↗ des formes proximales (cardia) et diffuses (linite) et ↘ des formes distales et ADK (par ↘ des FdR alimentaires et *H. pylori*)

Histologie	- Tumeur épithéliale maligne : adénocarcinome (90%) - Tumeur épithéliale bénigne : polype hyperplasique, adénome ou polype glandulo-kystique - Autres : tumeur endocrine, lymphome malin non hodgkinien, tumeur sous-muqueuse (dont tumeur stromale = GIST)		
	Classification de Lauren	- ADK de type intestinal glandulaire (90%) : sujet âgé surtout - ADK de type diffus (10%) à prédominance de cellules indépendants muco-sécrétantes (dont les linite) : sujet jeune surtout, prédominance féminine	
FdR	Helico-bacter pylori	= Facteur de risque d' adénocarcinome et de lymphome gastrique - Gastrite → gastrite chronique atrophique (25%) → métaplasie (15%) → dysplasie → adénocarcinome distal , généralement de type intestinal (chez < 1% des patients infectés) → <i>H. pylori</i> peut ne pas être retrouvé sur les biopsies gastriques d'un cancer et quand même être la cause (élimination secondaire) : recherche d'une infection par sérologie	
	Facteurs génétiques		→ Consultation oncogénétique si : atcds familiaux de cancer gastrique ou survenue précoce < 40 ans
		ADK gastrique diffus héréditaire	= Mutation autosomique dominante du gène CDH1 dans 30% des cas (perte de fonction des E-cadhérines) : à évoquer si 2 cas de cancer gastrique dont 1 < 50 ans sur 2 générations successives ou 3 cas indépendamment de l'âge au 1 ^{er} ou 2 nd degré - Porteur sain : - Gastrectomie prophylactique après 20 ans (pénétrance élevée) ou - Suivi par endoscopie gastrique avec chromo-endoscopie et biopsies - Chez les femmes porteuses de mutation : risque accru de cancer du sein
		Prédisposition génétique	- Apparentés au 1^{er} degré d'un cas de cancer gastrique - Syndrome de Lynch (HNPPC) ou polypose adénomateuse familiale → Recherche et traitement systématique d'une infection à <i>Helicobacter pylori</i> : par test respiratoire à l'urée < 45 ans ou par endoscopie digestive haute + biopsie > 45 ans
	Facteurs environnementaux	- Tabac - Consommation élevée de sel et de nitrites (charcuterie), faible consommation de fruits et légumes - Niveau socio-économique bas - Surcharge pondérale (facteur de risque d'ADK de la jonction oeso-gastrique)	
	Lésion pré-cancéreuse	- Gastrite chronique atrophique et métaplasie intestinale par infection à <i>Helicobacter pylori</i> - Maladie de Biermer (gastrite atrophique fundique auto-immune) : ADK et tumeur endocrine - Gastrectomie partielle pour affection bénigne : ↗ risque significative de 12 ans à 25 ans après chirurgie - Ulcère gastrique → endoscopie de contrôle avec biopsies systématique 1 mois après traitement - Maladie de Ménétrier : gastrite inflammatoire auto-immune - Polype gastrique adénomateux	
Diagnostic	C	= Longue phase asymptomatique, signes d'appel peu spécifiques et souvent tardif - AEG avec amaigrissement et dénutrition, anorexie - Syndrome ulcéreux ou syndrome dyspeptique - Syndrome obstructif : dysphagie au niveau du cardia ou vomissements au niveau du pylore - Complication : - Hémorragie digestive : anémie ferriprive, méléna, hématémèse - Péritonite par perforation gastrique - MT révélatrice : ganglion de Troisier, MT hépatique, pulmonaire, ovarienne (Krukenberg), carcinose péritonéale - Syndrome paranéoplasique : MTEV, acanthosis nigricans, anémie hémolytique, dermatomyosite, glomérulonéphrite extra-membraneuse, neuropathie périphérique	
	PC	Endoscopie oeso-gastro-duodénale	→ 5 à 8 biopsies sur les anomalies de relief muqueux, atteignant si possible la sous-muqueuse : - Siège de la lésion et étendue : de l' antre (40%), du corps (fundus : 20%), de la grosse tubérosité (20%) ou du cardia (< 2 cm de la jonction oeso-gastrique : 20%) - Distance par rapport au cardia et au pylore - Aspect macroscopique : ulcéro-végétante, végétante, ulcérante, infiltrante - Linite gastrique : muqueuse épaissie, hypertrophie des plis gastriques, biopsie (Se = 50%)
	DD	- Ulcère gastrique : risque de méconnaître un cancer si biopsies insuffisantes - Tumeur non adénocarcinomateuse : lymphome, tumeur stromale, tumeur endocrine, MT gastrique	

Bilan d'extension	Extension	- TDM thoraco-abdomino-pelvienne = bilan d'extension de référence : résécabilité, MT - Optionnel : - Echo-endoscopie : extension pariétale et ganglionnaire → utile en cas de suspicion de linite, de tumeur superficielle (éventuelle mucosectomie) ou avant traitement néo-adjuvant - Coelioscopie exploratrice si tumeur volumineuse de résécabilité douteuse		
	TNM	T1 = muqueuse (a), sous-muqueuse (b) T2 = musculuse T3 = sous-séreuse T4 = séreuse (a), organe de voisinage (b)	N1 = 1-2 ADP régionales N2 = 3-6 ADP régionales N3a = 7 à 15 ADP régionales N3b = ≥ 15 ADP régionales	M1 = métastase à distance (dont ADP sus-claviculaire, mésentérique, rétro-pancréatique et para-aortique)
	Stade	IA = T1N0 IB = T1N1 ou T2N0	IIA = T1N2 ou T2N1 ou T3N0 IIB = T1N3 ou T2N2 ou T3N1 ou T4aN0	III = T4aN1 ou T2N3 ou T3N2-3 IV = T4N+ ou tous M1
TTT curatif	Traitement chirurgical	= Exérèse complète de la tumeur avec curage ganglionnaire (≥ 15 ganglions) - Gastrectomie totale avec anse grêle montée en Y - Localisation à l'antre : gastrectomie des 4/5^{ème} avec anastomose gastro-jéjunale		
	Traitement endoscopique	= Mucosectomie ou dissection sous-muqueuse - Indication : adénocarcinome intestinal limité à la muqueuse (T1a), non ulcéré		
	Chimiothérapie néo-adjuvant	= Chimiothérapie péri-opératoire (pré- et post-opératoire) : épirubicine + 5FU + cisplatine - Indication : proposée à tout malade de stade ≥ II (≥ T1N2, T2N1 ou T3N0)		
	Traitement adjuvant	= Radio-chimiothérapie (5FU) post-opératoire : si aucune chimiothérapie pré-opératoire et - Curage insuffisant et tumeur de stade ≥ 2 - Envahissement ganglionnaire pN2 ou pN3 quel que soit le curage - A discuter si envahissement ganglionnaire pN1 avec curage suffisant		
TTT palliatif	Traitement symptomatique	- Chirurgie d'exérèse palliative si tumeur symptomatique (hémorragie ou sténose) - Radiothérapie hémostatique si hémorragie - Pose de prothèse métallique expansive par voie endoscopique si occlusion tumorale haute		
	Chimiothérapie	- Chimiothérapie : épirubicine + cisplatine + 5FU ± Thérapie ciblée : trastuzumab (Herceptin®) si surexpression d'HER2 (< 20% des cas)		
Evolution	Pronostic	- Cancer de mauvais pronostic = 15% de survie à 5 ans (tous stades confondus) - Facteur pronostique principal = envahissement ganglionnaire : survie = 60% si N0, 35% si N1, 10% si N2		
	Suivi	→ Surveillance pendant 5 ans après traitement curatif chez tous patient susceptible de supporter une réintervention ou une chimiothérapie - Tous les 6 mois : examen clinique + échographie abdominale - 1/an : NFS (anémie post-gastrectomie : carence martiale ou en vitamine B12) + RP ou TDM		
		Après gastrectomie partielle	- Endoscopie de surveillance du moignon après 10-15 ans	
		Après gastrectomie totale	- Dumping syndrome - Anémie carentielle : supplémentation IM en vitamine B12 - Autre : syndrome du petit estomac , diarrhée chronique (section du n. vague), oesophagite (reflux biliaire), dénutrition , ulcère anastomotique	

FORMES PARTICULIÈRES

Adénocarcinome	ADK du cardia	= Cancer de la jonction oeso-gastrique (< 2 cm de la jonction oeso-gastrique) : en ↗ d'incidence - Souvent révélé par une dysphagie	
	ADK superficiel	= Cancer ne dépassant pas la sous-muqueuse : de bon pronostic (survie à 5 ans > 90%) - Présentation : forme pseudo-ulcéreuse (fréquente), polypoïde, surélevé, plan ou déprimé - TTT : mucosectomie endoscopique en cas de cancer superficiel respectant la <i>muscularis mucosae</i> (T1) après évaluation écho-endoscopique	
	Linite gastrique	= ADK peu différencié , constitué de cellules indépendantes (en « bague à chaton ») envahissant les différentes couches gastriques sans les détruire, associé à un stroma fibreux - 10% des cancers gastriques : sujet plus jeune, à prédominance féminine, de mauvais pronostic - Extension : principalement lymphatique et péritonéale	
		C	- Souvent révélé par un AEG avec amaigrissement ± signes d'occlusion haute
		PC	- Endoscopie : gros plis rigides sans aspect tumoral, insufflation complète de l'estomac non obtenue, biopsies souvent négative (50% de sensibilité : respect fréquent de la muqueuse) - TDM ou TOGD : aspect figé et rétréci de l'estomac - Echo-endoscopie : épaississement de la paroi gastrique prédominant au niveau sous-muqueux
TTT	- Exérèse chirurgicale : rarement curative → Très peu chimiosensible		
Autres	Lymphome gastrique primitif	= Les plus fréquents des lymphomes non hodgkiniens non ganglionnaires : 3% des tumeurs gastriques	
		Lymphome gastrique du MALT	= Petites cellules de bas grade de malignité : lié à l'infection chronique à <i>Helicobacter pylori</i> , d'évolution très lente - Souvent peu symptomatique - Endoscopie : lésions pseudo-inflammatoires ou tumorales - Régression du lymphome dans 70% des cas après éradication de <i>H. pylori</i>
		Lymphome gastrique à grandes cellules	= De haut grade de malignité : rare - Tumeur volumineuse et ulcérée - TTT : polychimiothérapie
	Tumeur stromale (GIST)	= Tumeur mésenchymateuse rare : situé dans 2/3 des cas au niveau de la couche musculieuse - Souvent asymptomatique de découverte fortuite, ou hémorragie, masse palpable, perforation - Endoscopie, TDM, écho-endoscopie : masse ronde sous-muqueuse , parfois ulcérée, avec développement exo-gastrique fréquent - Expression immuno-histo-chimique d'un récepteur membranaire c-kit - TTT : - Exérèse chirurgicale monobloc sans curage ganglionnaire extensif - Non résécable/métastatique ou en adjuvant si risque de rechute : imatinib (Glivec®)	
	Tumeur endocrine	- Sur une maladie de Biermer : multiples, de petite taille, d'évolution lente, MT exceptionnelle - Sporadique (très rare) : carcinome peu différencié , de mauvais pronostic	